

A close-up photograph of a patient's hand resting on a white hospital bedsheet. The hand is wearing a clear medical wristband and has several clear plastic tubes (likely for IV or monitoring) attached to it. The background is a blurred hospital room with medical equipment and other beds, suggesting an ICU setting. The overall tone is calm and professional.

ICUの人的ケア

Human care を積み重ねて、ICUを Humanization する



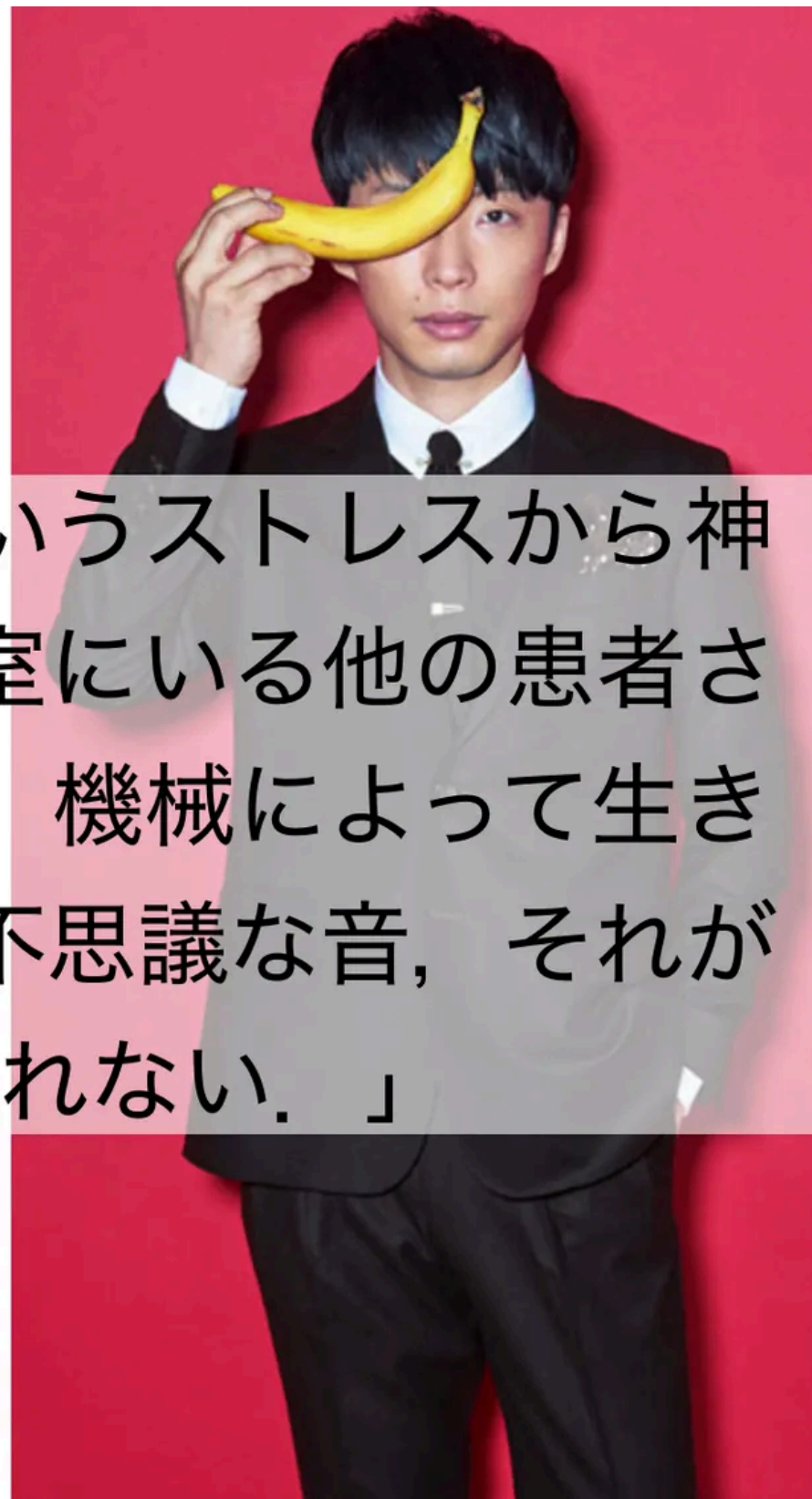
2012年

くも膜下出血手術

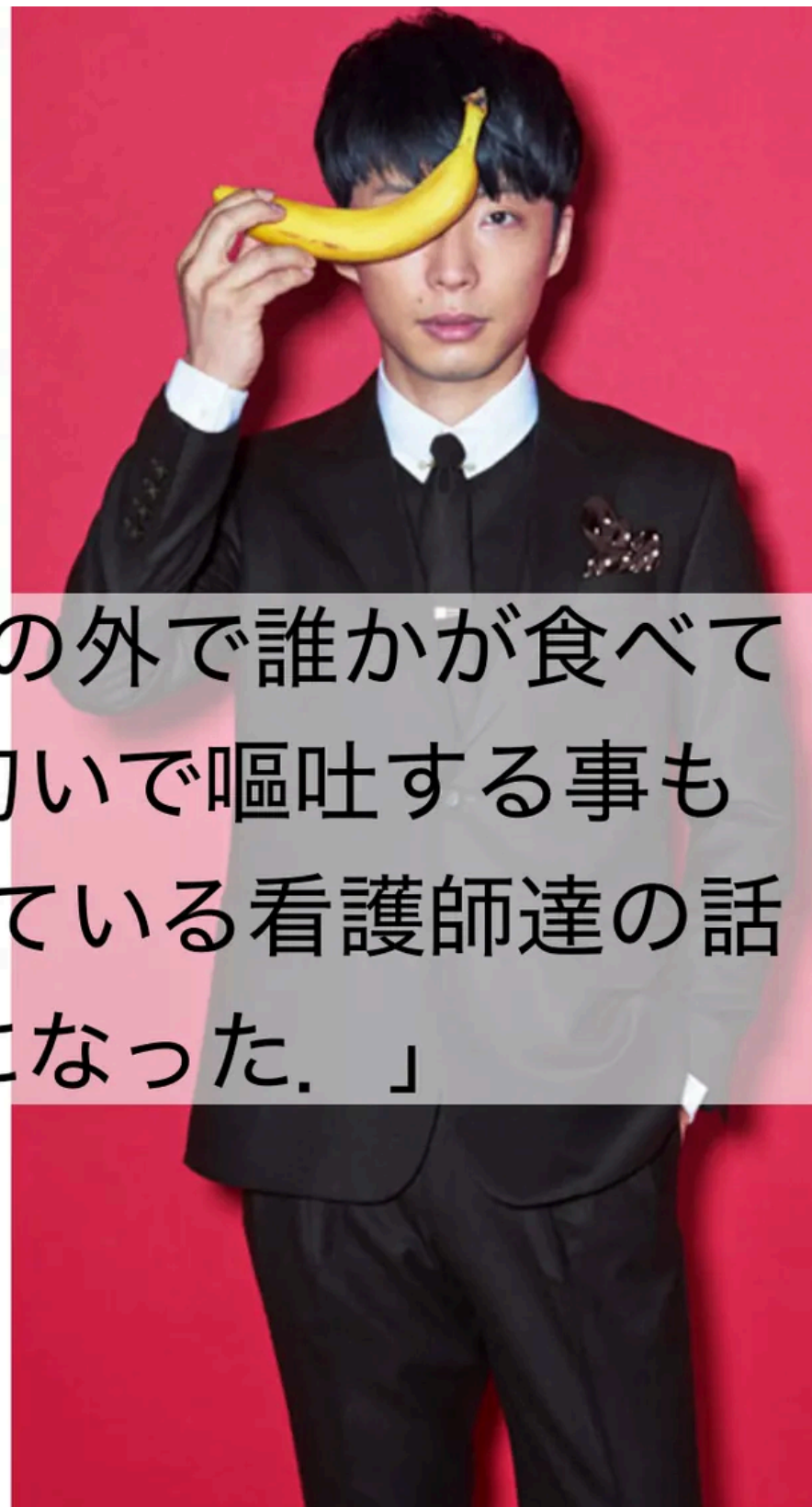
2013年

くも膜下出血手術

「体が動かせなくなるというストレスから神経過敏になり，集中治療室にいる他の患者さんのうめき声，息づかい，機械によって生きている患者さんから出る不思議な音，それが気になって全く眠れない。」

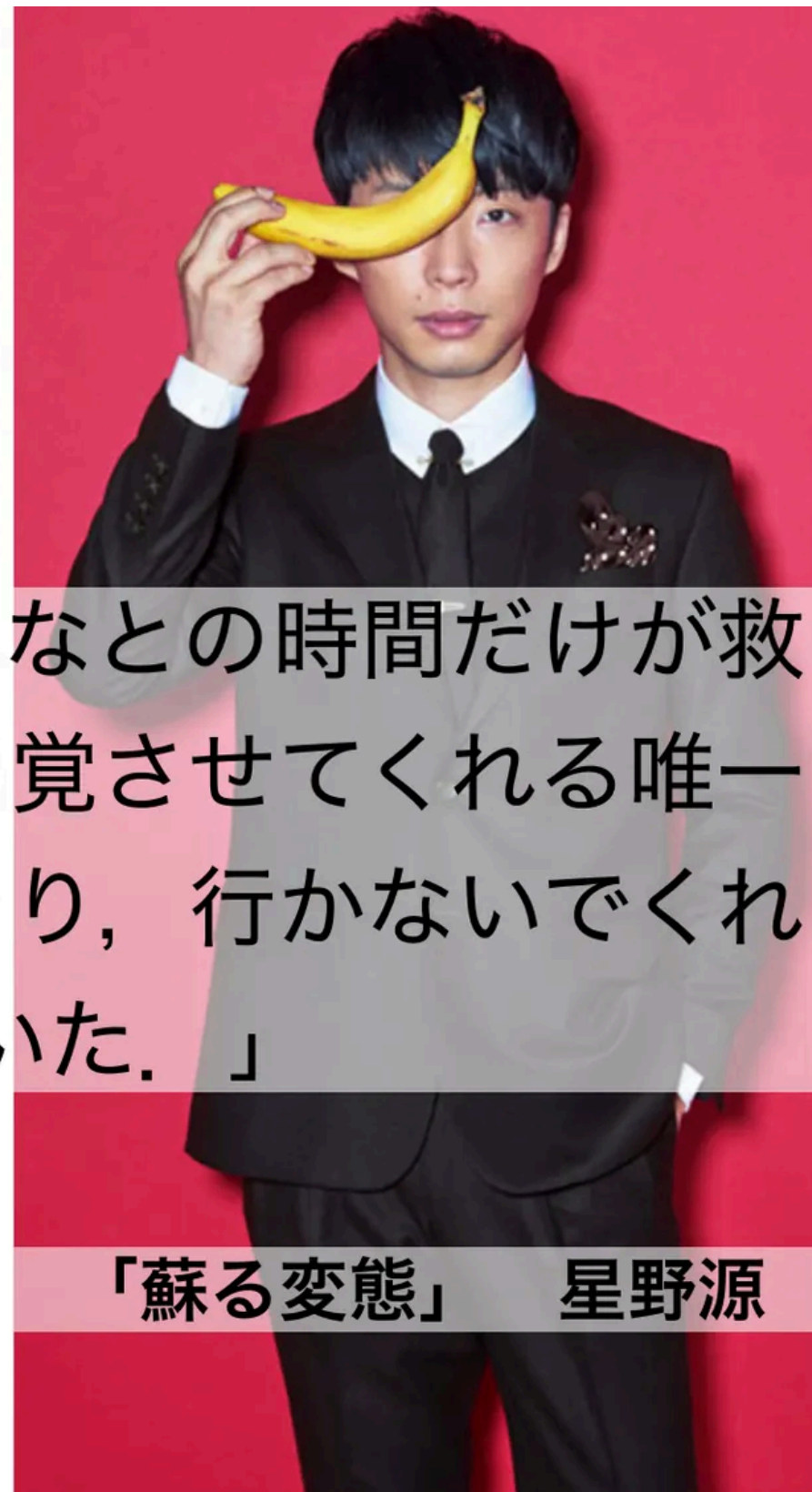


「時には深夜に集中治療室の外で誰かが食べて
いるであろうクッキーの匂いで嘔吐する事も
あった。 遠くの方で聴こえている看護師達の話
し声に発狂しそうになった。」



「お見舞いに来てくれるみんなとの時間だけが救
いだった。自分が何者かを自覚させてくれる唯一
の時間。皆が帰った後、ひとり、行かないでくれ
と声を殺して泣いた。」

「蘇る変態」 星野源



2つの言葉を分けて使う

Human care を積み重ねて、ICUを Humanization する

Humanization（目指す姿）

- 患者と家族を一人の人として尊重できるICUへ
- ケアだけでなく環境・仕組み・働き方まで
- ICU全体で整えていく考え方

Human care（日々の実践）

- 患者と家族を一人の人として尊重するケア
- 一人ひとりがベッドサイドで行う
- Humanizationを実現する手段

今日持ち帰る3つ

1

患者は起きている。聞けば苦痛は見える
口渇・不安・呼吸困難・睡眠を毎日尋ねる

2

善意は時刻表と実施率に落とす
「頼まれたらやる」は、ほぼ届いていない

3

家族と医療者も当事者
面会を開いて接点ごとに手当て。医療者のケアも人間化

最初に押さえる6つの数字

初日に口渇がある

66 %

症状で最多・最強

口渇を自分から訴えた

20 %

聞けば7割が答える

人工呼吸中の呼吸困難

約40 %

VASで平均45 mm

頼まれたら式の保湿

0.5 回/7時間

時刻表なら4.4回

ABCDEFと院内死亡

0.32 aHR

非ランダム化の関連

柔軟な面会の家族PTSD

21 %

通常の面会は30.5%

第 1 章

01

治療のフォーカス

臓器から、患者・家族・医療者へ

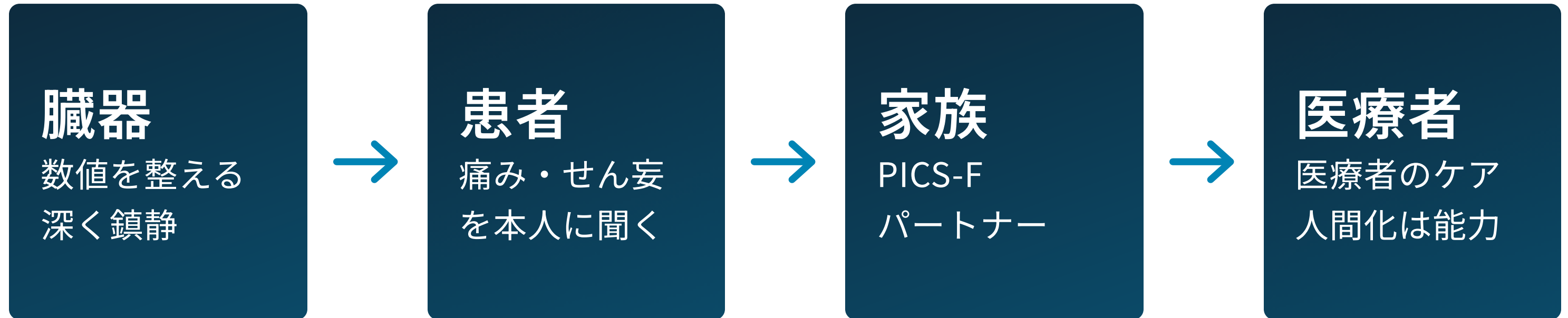


患者は何を語っているか

「人に囲まれていて、
これほど孤独になれるとは知らなかった」

「私は「4号室のあの患者」ではなかった」

フォーカスは、臓器から医療者へ広がった



PAD 2013 → PADIS 2018・2025

眠らせ方から、痛み・不穏・せん妄の管理へ

前の段を捨てない

質の高い医療の上に Human care が乗る

非人間化とは、人を「物」として扱うこと

患者が失うもの

- アイデンティティ
- 意思を伝える力
- 自分のことを伝える力
- 敬意とプライバシー

人間化の小さな実践

- 面会を開く・触れる
- 病気以外のことも話す
- せん妄の患者にも礼儀正しく
- 眼鏡・補聴器・口腔ケア

ICUの環境そのものが、非人間化を生みやすい

非人間化は、構造から生まれる

層	非人間的なケアを生む条件
社会・法制度	権利の否認、利益への関心、資源の不足
病院組織	断片化されたケア、ルーチン化、多重業務
個人	直接ケアの不足、患者の孤立、身体への偏り
くびれ	ベッドサイドに看護師がいること・情報提供

人間的なケアは「看護師だけの決断ではない」

国際的な枠組み：HU-CIの7領域

領域	中身
オープンドア	面会の開放。家族はケアのパートナー
コミュニケーション	チーム・患者・家族の対話、AAC
患者の well-being	痛み・口渇・寒さ・不眠・孤独・恐怖
医療者へのケア	燃え尽き・共感疲労・休む場所
PICS	退室後の不調の予防と早期発見
人間化された環境	自然光・プライバシー・居場所
終末期ケア	緩和ケアの統合、意思決定の支援

第2章

02

深鎮静の時代は終わった

起きている患者は、苦痛を伝えられる



深鎮静は「既定値」ではなく「例外」

深鎮静の害（18項目の例）

- 人との接触の喪失
- せん妄・ICU-AW
- 人工呼吸と滞在の延長
- 永続的な認知障害

深い鎮静が要る5場面

- 非同調を伴う重症呼吸不全
- 筋弛緩薬の使用
- てんかん重積
- 頭蓋内圧亢進の一部 など

人員不足は深鎮静の理由にならない

鎮痛を先に、鎮静は最小に、ケアは最大に

鎮痛を先に

多角的鎮痛で
オピオイド減



鎮静は最小に

RASS -1~0
ベンゾは限定



ケアを最大に

睡眠・離床
対話と面会

目指す姿は3C

Calm・Comfortable・Cooperative

興奮したら、まず原因

痛み・せん妄・非同調・便秘を探す

PADIS 2025：不安は新領域、推奨はまだない

問い	推奨（条件付き）	ポイント
鎮静薬	デクスメトミジンを提案	せん妄 RR 0.55、徐脈 RR 1.65
リハビリ	強化リハビリを提案	ICU-AW RR 0.77（high）
睡眠	メラトニンの投与を提案	睡眠時間は延びない
不安	推奨不能（根拠なし）	まず測ることから
せん妄	抗精神病薬は推奨不能	原因の除去と非薬物的ケア

起こした患者は、孤独と言えない苦しさを抱える

覚醒した患者の体験

- 言葉も道具も使えない
- 伝わらないと消耗する
- 人に囲まれていても孤独
- 病気以外の自分を見てほしい

1/4超

鎮静中断6時間後の重度の不安

伝えられないことが最悪の体験

人工呼吸の患者の語りの統合

起こすことは責任を引き受けること

次の章：聞いて、測る

第3章

03

聞かなければ存在しない

口渇・不安・呼吸困難・睡眠を尋ねる

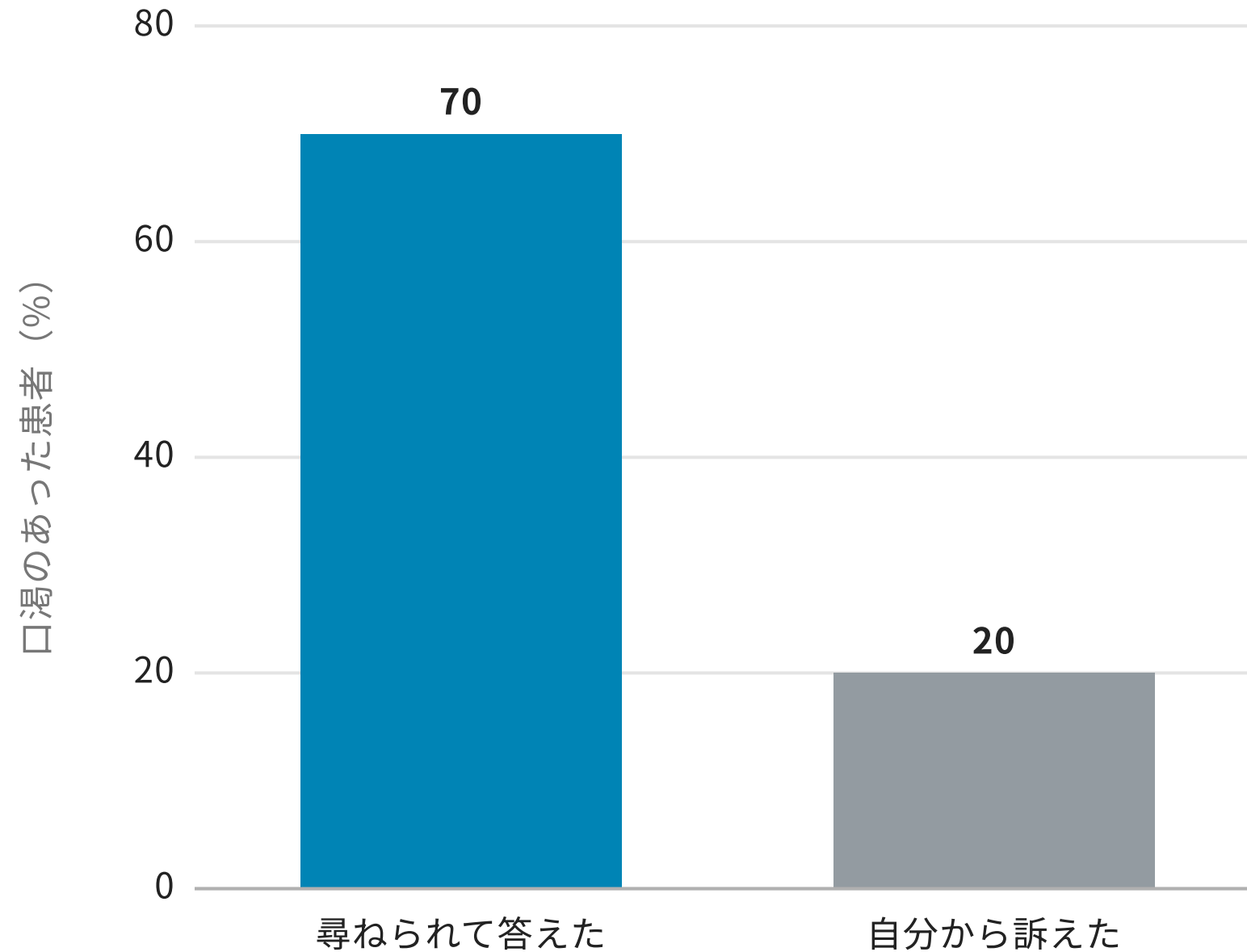


多いのは口渇、苦しいのは不安

指標	1位の症状	値
初日の有病率	口渇	66%
初日の平均の強さ（0～10）	口渇	6.13
7日間の有病率	口渇	64%
初日の平均の苦痛度（0～10）	不安	5.24
7日間の平均の苦痛度（0～10）	不安	5.46

強さだけで優先順位をつけると、不安を取りこぼす

口渇の8割は、聞かれて初めて出てくる



待っていると2割
聞けば7割が答える

ケアの効果は1時間
1時間で元に戻った

湿っていても渇いている
口渇と口腔の水分は無相関

毎日尋ねる5つ「iPad 2」

頭文字	訴え	聞き方の例
I	Insomnia（不眠）	夜は眠れましたか
P	Pain（痛み）	どこが、どのくらい痛みますか
A	Anxiety（不安）	怖い・落ち着かないことはありますか
D	Dry mouth（口渇）	喉が渇いていませんか
D	Dyspnea（呼吸困難）	息が苦しくありませんか

答えられない患者には、うなずき・文字盤・指差しで答えられる形で聞く

道具は、検証された集団で使う

測るもの	道具	注意
口渇	NRS 2問（強さ・苦しさ）	重度7～10。TDSはICU未検証
睡眠	RCSQ（日本語版あり）	総得点だけ。非挿管・せん妄なし
挿管患者	TOURS（4項目）	1日2回。転帰との関係は未検証
不安	Faces Anxiety Scale	推奨はまだない
呼吸困難	VAS・NRS	人工呼吸中の約40%

ICU患者の最大半数は答えられない。「測れなかった」も記録する

呼吸困難は、痛みと同じく緩和の対象

陽性なら探すこと

- 換気設定（非同調）
- 不安・痛み
- 分泌物・気道
- それでも残れば緩和

約40%

人工呼吸中に呼吸困難を報告

強さは VAS 45 mm

0～100 mm の平均

モニターの値が良くても苦しい

すべての患者で同定・予防・緩和

話せない患者に、伝える手段を渡す

渡す手段

- 眼鏡・補聴器・入れ歯を戻す
- はい／いいえの合図を決める
- 文字盤・筆談・タブレット
- 気管切開なら発声の手段

しないこと

- 患者の頭の上で話す
- 説明せずに処置する
- 患者の前で苦痛な発言
- 答えを急かす

非人間化は、コミュニケーションの場面で最も起きやすい

第 4 章

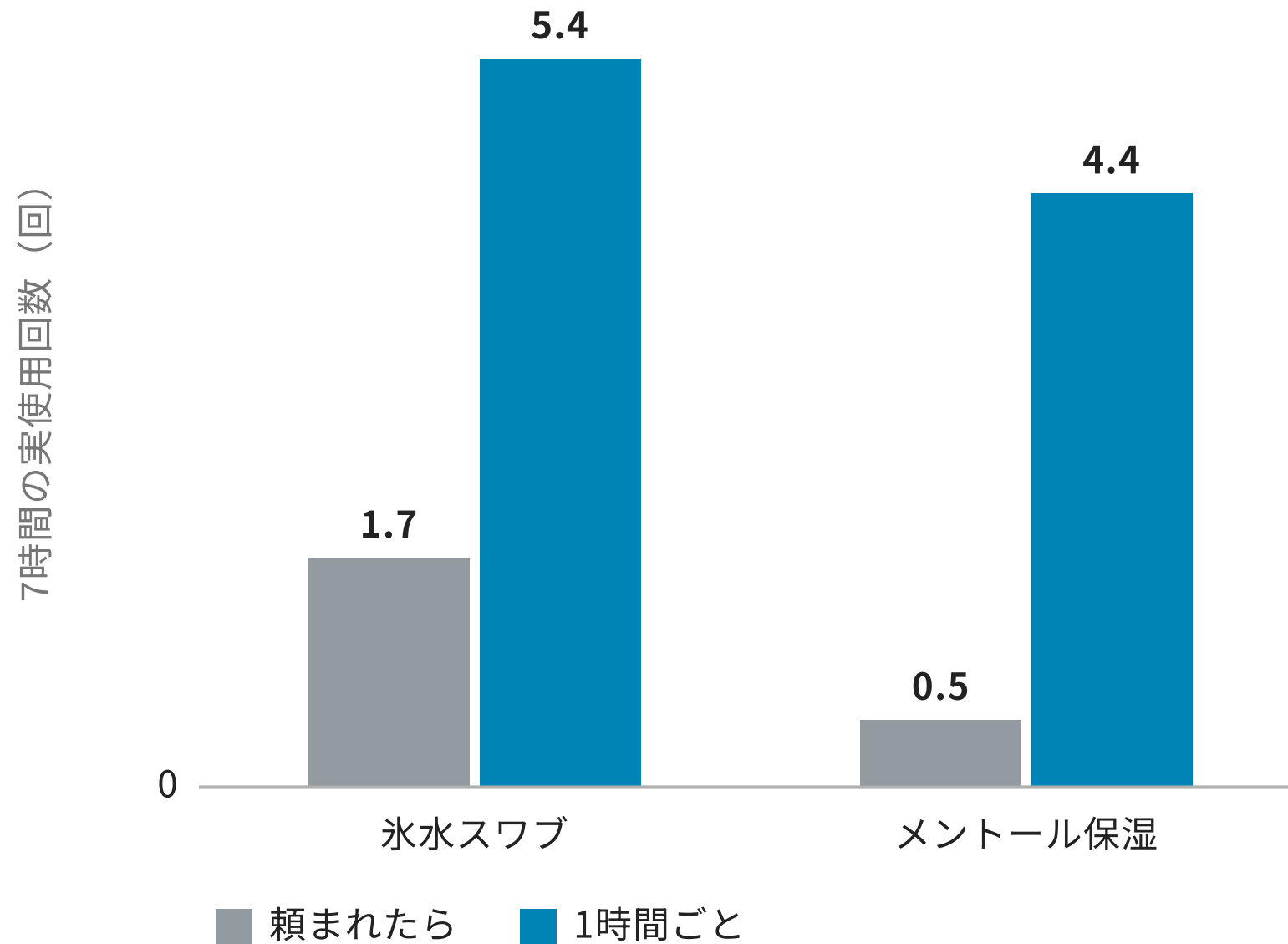
04

善意は時刻表に載せる

届いた割合が転帰を変える



「頼まれたらやる」は、ほぼ届いていない



0.5回

頼まれたら式の7時間の保湿

口渴の強さ -2.84 対 -1.68

$P=.02$ 、苦しさは有意差なし

非ランダム化・挿管例ほぼなし
強さを誇張しない

1時間で戻るから、1時間ごとに

研究	デザイン	主な結果
Puntillo 2014	RCT・252名	口渇 5.9→3.6（対照4.7）
Kalfon 2017	クラスターRCT	口渇 2.32 対 3.40
Zhang 2021	RCT・61名	口渇 6.69→5.42
Lemyze 2020	前後比較・26名	ミント氷で 8.5→4.0
Doi 2021	観察・86名	効果が保たれたのは1時間

口渇は消えない。答えは「時刻表に載せる」

ABCDEFは、届いた割合に比例して効く

アウトカム	完全実施（95%CI）
7日以内の院内死亡	aHR 0.32（0.17–0.62）
せん妄	aOR 0.60（0.49–0.72）
身体抑制の使用	aOR 0.37（0.30–0.46）
ICU再入室	aOR 0.54（0.37–0.79）
有意な痛みの報告	実施割合とともに増加

痛みの報告の増加は「見えるようになった」から

身体抑制は、監視すべき有害事象

抑制するなら記録

- 理由（行動か、予防か）
- 部位の数と総時間
- 誰が決めたか・指示
- 家族への説明

8%

抑制されていた患者

医師の指示があったのは52%

家族への通知の確認は38%

抑制の前に原因を探す

痛み・口渇・尿意・せん妄

第 5 章

05

人として扱う

つながりと、名前を呼ぶこと



人間的だと感じるのは「つながり」を感じたとき

誰の	主題
患者	医療者とのつながり：目を見る・微笑む・触れる
患者	自分とのつながり：情報・清潔ケア・整容
患者	外の生活とのつながり：ラジオ・花火
家族	唯一無二の人として世話されているのを見る
家族	そばにいる・触れる
家族	自分たちもケアされる

効いているのは高価な介入ではなく、小さなこと

ラインの奥に踏み出す



毎回やること

- 名乗り、呼ばれたい名前と呼ぶ
- 目線を合わせ、本人に向かって話す
- 処置の前に、何をするか伝える
- 日付・時刻・場所・予定を伝える
- 帰り際に「ほかに困りごとは」

その人を知るボードは、使って初めて効く

Get to Know Me Board

- 呼ばれたい名前
- 趣味・大切なもの
- 元気が出ること
- 回診でそれを見て話す

90%・99%

患者・家族が「重要」と回答

家族の85%が「名前」を有用

患者は28%

「誰も使わなかった」 17%

掛けてあるだけでは失敗

希望を叶える工夫は、受け入れられても効果は未確立

試みられていること

- 音楽（多くはヘッドホン）
- 動物の面会
- ICU専用のVR
- 家族の声をAIで再現（構想）

わかっていること

- 音楽の効果のエビデンスは限られる
- ペット面会は全工程2時間超
- VRは満足度8/10でも効果なし
- AIの声は有効性データなし

満足度は「受け入れられる」の指標で、「効く」の指標ではない

第 6 章

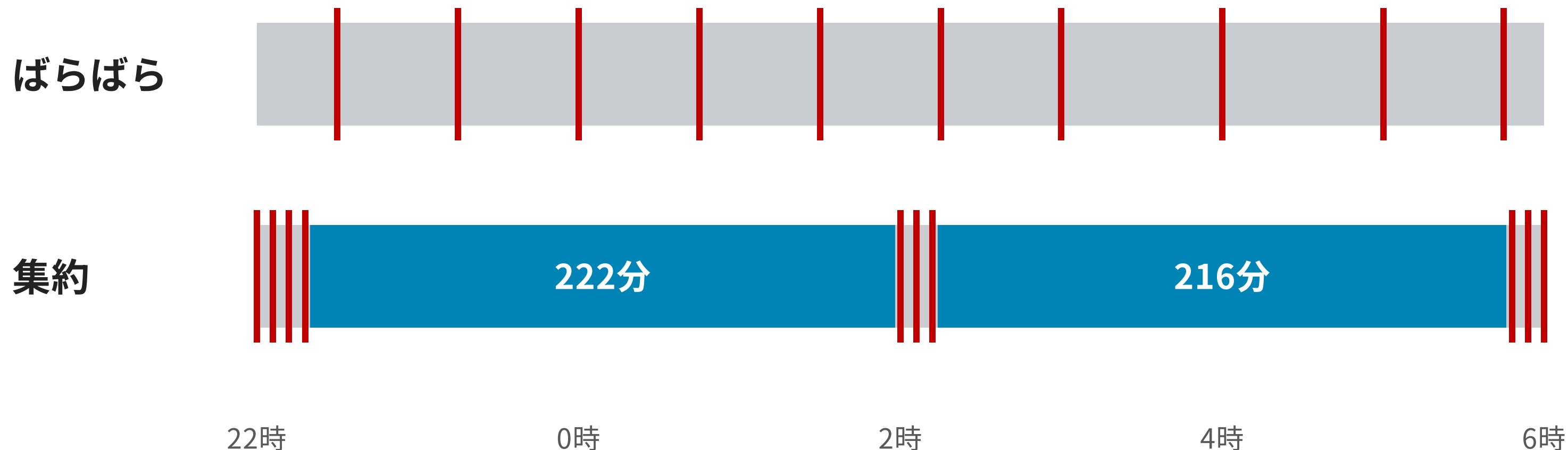
06

夜は静かに暗く

環境は単独でなくバンドルで



夜は、90分以上触らない時間をつくる



同じ回数のケアでも、まとめれば眠れる

大きな音は、患者の耳のすぐ横から

今日確認できること

- アラーム音量が毎回標準に戻らないか
- 患者の頭の近くで申し送りしない
- 個室のドアの外で噂をしない
- 測るなら大きな音の回数

44～66.5 dBA

ICUの平均音圧（WHOは昼35）

ピークは申し送りと回診

100 dBA超が1時間に2回

騒音の半分以上は職員の声

単発の掲示や教育は元に戻る

単独の環境介入は、大規模RCTで陰性

介入・測定	わかっていること	言い方
夜の光	20 lux超が1時間に7～16回	暗闇の断片化を見る
日中の高照度光	734名のRCTで陰性	単独では効かない
メラトニン	予防847名で陰性・PADISは提案	環境を整えたうえで
耳栓・アイマスク	文献間で食い違う	バンドルの一部
睡眠覚醒調節薬	せん妄 RR 0.60・低確実性	全例には使わない

光・耳栓・静穏時間は、ばらばらでなくバンドルで

ICUの設計も治療の一部。約束は環境の指標まで

わかっていること

- 個室化で残響0.7→0.3秒
- 遮音0→21 dBA
- 測定は患者が入る前の空室
- 家族の居場所は best practice

提案するときは

- 何を測るかを着工前に決める
- 体験と環境の指標で約束する
- 家族と職員の居場所も同じ計画に
- 価値で定義する

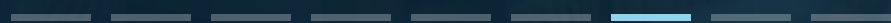
「せん妄が減ります」と言って予算を取らない

第7章

07

家族はケアのパートナー

面会を開き、接点に手当てを



PICS-Fは家族の20～60%、生活まで揺さぶる

家族に起きること

- 不安・抑うつ・PTSD
- 仕事を離れる
- 貯蓄を失う
- 時間では解決しないことも

20～60%

PICS-Fが起きる家族

1か月で44.9%が離職

1年で36.7%が貯蓄を失う

家族の約3割にPTSD症状

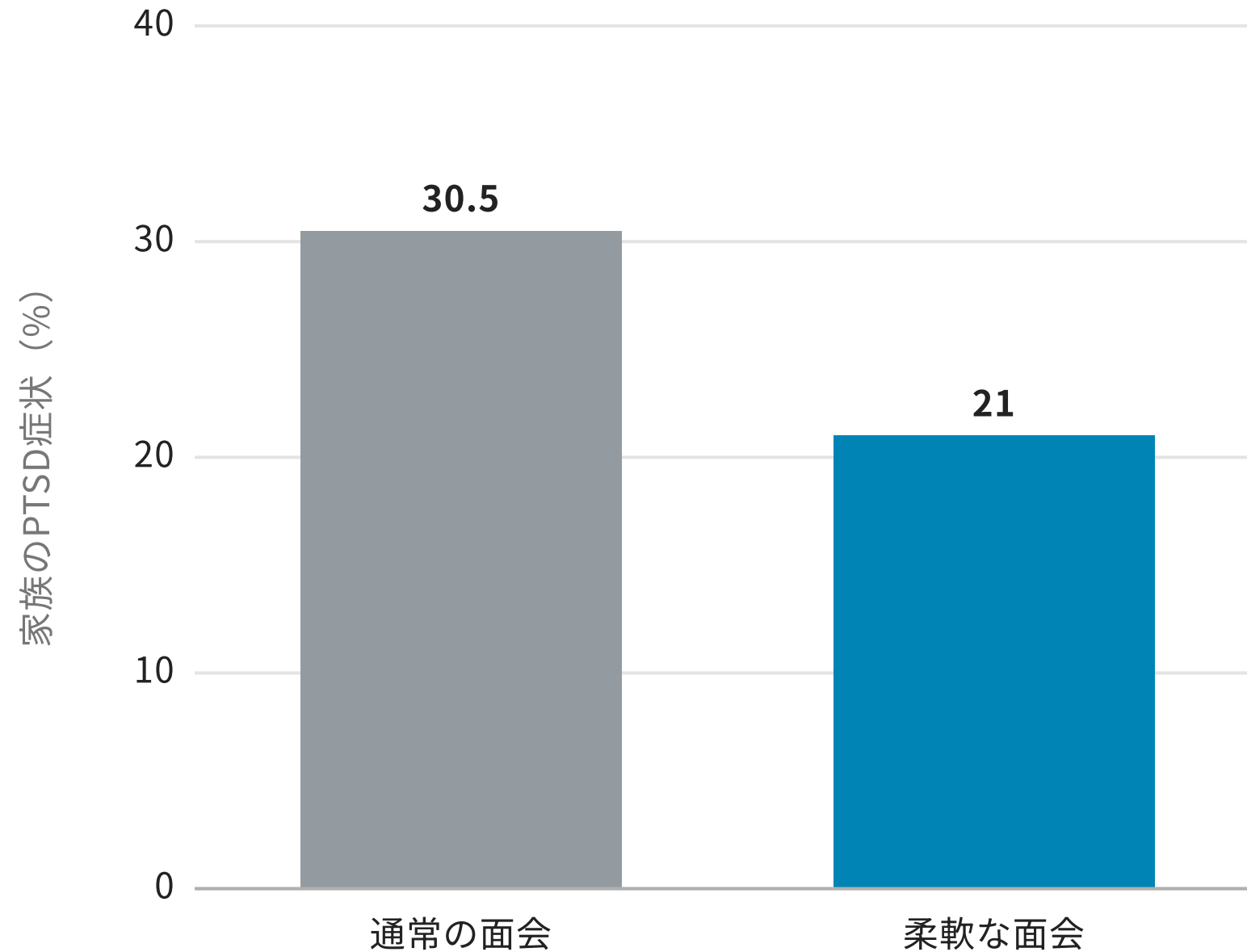
方針と指標は疾患と稼働だけ

面会の緩和が、唯一の「強い推奨」

ステートメント	強さ（確実性）
面会を緩和した方針をICUの既定とする	強い（low）
家族向けの教育プログラム	条件付き（moderate）
回診への同席・ケアへの参加	条件付き（low）
家族カンファの標準化とVALUE	条件付き（low）
家族向けの意思決定支援ツール	推奨せず

家族は visitor ではなく partner in care

柔軟な面会が効くのは、家族の心理



患者のせん妄は差なし
18.9% 対 20.1%

面会4.9時間 対 1.5時間
構造化ミーティングと冊子つき

感染・燃え尽きは増えない
時間だけ延ばすと外れうる

家族の引き金は、滞在の全体に散らばる

初回面会の前

チューブの本数・目が開いているか・抑制・むくみを予告

待っている間

家族自身の睡眠と食事を尋ねる

覚醒の前日

せん妄は起こりうる・一過性・人格ではないと伝える

看取り

モニター表示を消すかを選んでもらい、死戦期呼吸を先に伝える

一度の面談に頼らない

それぞれの接点に予告と説明を置く

面談はVALUEで

頭文字	すること
V Value	家族の言ったことの価値を認める
A Acknowledge	家族の感情に気づいていると伝える
L Listen	よく聴く
U Understand	患者がどんな人だったかを尋ねる
E Elicit	家族からの質問を引き出す

患者を人として語る一文と、家族の体調を聞く一文を

担い手を1人足しても、家族の心理は動かなかった

試験	足したもの	家族の心理
PARTNER	多職種チームの支援	差なし
FICUS	指名の家族ナース	8項目すべて差なし
ファシリテーター	看護師が3か月伴走	抑うつ差 -0.07点
Caregiver Pathway	4つの時点で接点	IES-R 6.8点低下

効いたのは面会を開くことと、接点を複数置くこと

陰性試験は「無効」の証明ではない

なぜ陰性になりうるか

- 割付単位が16施設だけ
- 予後因子の約45%が偏りうる
- 長期の不安・抑うつは動かず
- 動いたのは医療チームとの関係

次の照準

- 全家族に一律に足さない
- 負担の大きい家族に絞る
- 対立・代理意思決定者の不在
- 短期の当事者中心アウトカム

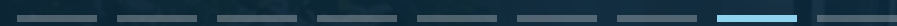
「効果なし」と「まだ測れていない」を分けて読む

第 8 章

08

ICUのあとと医療者

回復は続き、人間的なケアは能力



PICSは、入室の日から動く回復の過程

ゴールは生活に戻ること

- 家庭
- 趣味
- 仕事
- 家族と一緒に

64%

J-PICS：日本のICU患者のPICS

確実なのはICUにいる間の予防

浅い鎮静・せん妄予防・早期離床

退室時に4項目を手渡す

リハ・離床・栄養・残るリスク

ICUダイアリーの価値は、つながりにある

わかったこと

- 3か月PTSD 29.9% 対 34.3%
- 差なし（657例・P=0.39）
- 妄想的記憶38.5%がPTSDに
- 健忘にしてもPTSDは減らない

どう使うか

- 目的をPTSD予防にしない
- 記憶の補完と家族の支えに
- 医療者も人間化される
- 記憶を消す鎮静はしない

ダイアリーは「医療スタッフと患者の双方を人間化した」

医療者へのケア：共有する傷の5つの枠組み

頭文字	中身
A 家族を受け入れる	家族支援を職務の必須要素に
B 燃え尽きを防ぐ	個人の研修より、人員配置と心理支援
C 倫理的な風土	関係性の能力を訓練する
D 時間を確保する	時間は関係性ケアの通貨
E 励ます	守られた時間と研修の資金

疲れ切ったチームは、人間的なケアを届けられない

燃え尽きは、職場の仕組みで下がる

Hello trial（6要素を4週間）の例

- 朝の挨拶
- 感謝のメッセージ
- リーダーの率先
- 費用はほぼかからない

aOR 0.56

バーンアウト 63.3% → 52.2%

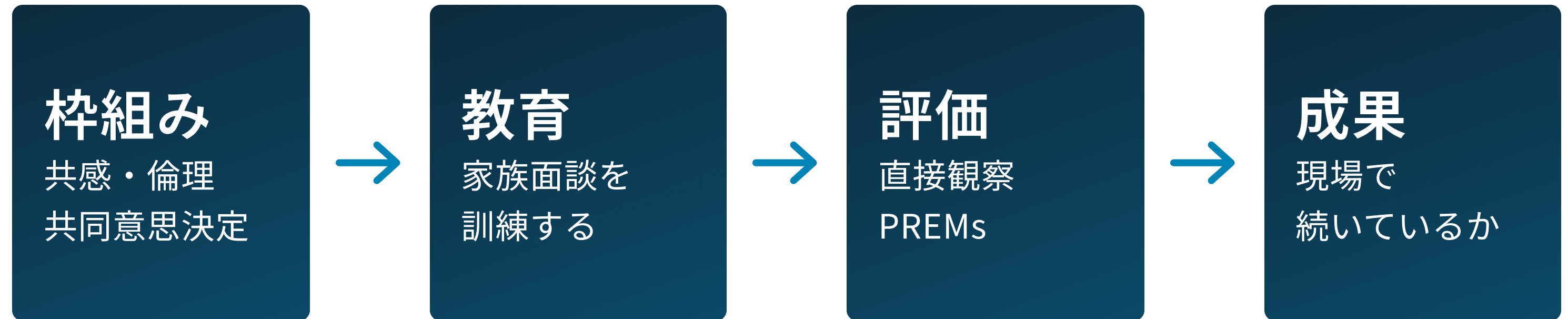
モラルディストレスの原因は構造

病院の文化・職種の階層・治療を
減らす手続きの不足

効くのは研修より権限

看護師が緩和ケア・倫理コンサルを依頼できる

人間的なケアは、教えて評価する能力



家族面談をシミュレーション
急変対応と同じように多職種で

善意だけでは続かない
研修を受けた、で終わらせない

第9章

09

聖路加ICUの Hotel ICU

6つの柱と、ICUの前・中・後をつなぐケア



Hotel ICU：6つの柱

医療者へ

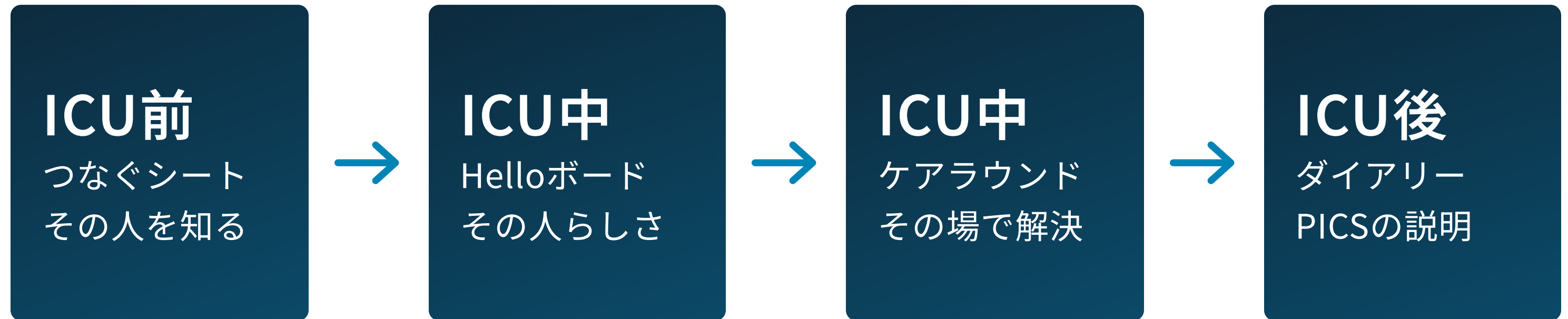
- 04 働きやすい環境
- 05 スタッフの Wellbeing
- 06 プロとしての満足感



患者さん・ご家族へ

- 01 ホスピタリティー
- 02 Human Care
- 03 質の高い医療

ICUの前・中・後をつなぐ4つの施策



いまの力点はケアラウンド
ICUにいる間の予防へ

文献との対応
その人を知るボード・日記

退室後訪問で聞いた声（2024年度）

多職種で訪問

22 人

4日以上の33人のうち

つらかったことがあった

13 人

呼吸に関する記憶が多い

口渇を覚えていた

約3 割

22人のうち7人

- 見えた限界：苦痛を知るのは、それが「過去のこと」になってから
- だから力点を、ICUにいる間の予防＝ケアラウンドへ移した

ケアラウンド：多職種で週2回、ベッドサイドへ

	どう回っているか
誰に	意思の疎通ができる方。せん妄・挿管中も対象
誰が	医師・看護師・薬剤師・栄養士・理学療法士の2人以上
いつ	週2回（月・金）。1人約10分
何を	30項目で見て、その場で介入し記録
翌日	受け持ち看護師が結果を評価

パイロットで最も多かった訴えは口渇。その場で対応できている

ICUを出たあとも、つながる

ICUダイアリー

- 人工呼吸24時間以上の見込みの方
- ICUの看護師が書き始める
- 病棟で本人に手渡し、記憶を伺う
- 渡せないときはご家族へ

PICSの説明

- パンフレットを患者さんにご家族へ
- 体・心・認知の不調を伝える
- 相談先を明記
- 院内のPICSチームで対応

文献どおり、ダイアリーは記憶の補完とつながりのために



言えること・言えないこと

介入	言えること	言えないこと
口渇ケア	口渇が下がる	せん妄が減る
ABCDEF	用量反応の関連	因果としての死亡減少
柔軟な面会	家族の心理の改善	患者のせん妄の減少
ICUダイアリー	家族・医療者とのつながり	患者のPTSD予防
環境・設計	環境の指標の改善	転帰の改善

効果が未証明でも、やらなくてよいわけではない

明日からの3つ

1

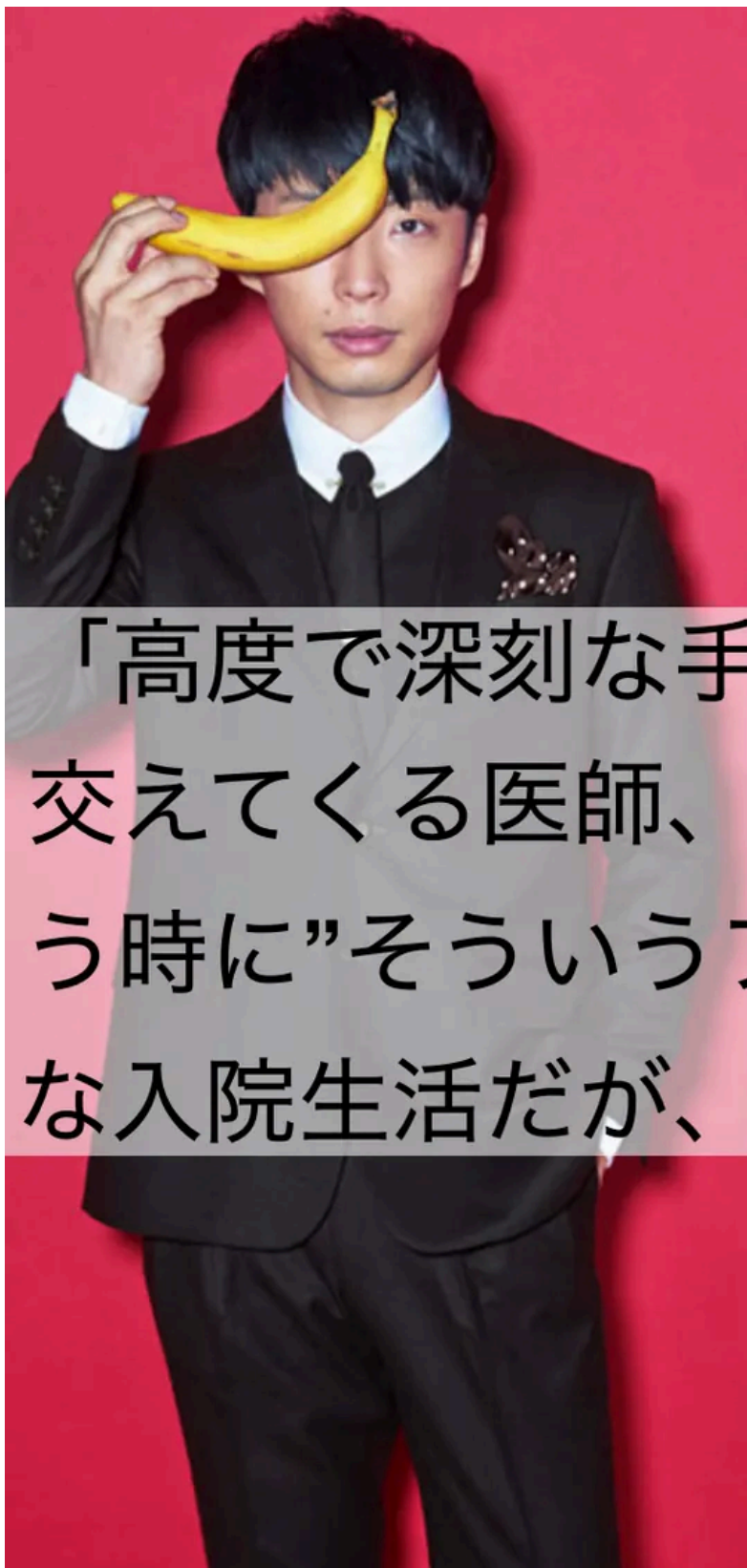
患者の声に耳を傾け、手を添える
毎日 iPad 2 を尋ね、口渇ケアを時刻表に

2

人として向き合う
名前を呼び、処置の前に声を掛ける

3

家族と仲間にも目を向ける
初回面会の前に予告。夜は90分触らない



「高度で深刻な手術内容を説明しながら下ネタを交えてくる医師、美人看護師に座薬を入れてもらう時に”そういうプレイだ”と妄想する自分。過酷な入院生活だが、**面白さが辛さに勝ったのだ。」**

確認クイズ：○か×か

Q1 柔軟な面会は、患者のせん妄を減らす

Q2 口渇は、聞かなくても患者が訴えてくれる

Q3 口が湿っていれば、口渇はない

Q4 ABCDEFは実施割合が高いほど転帰が良い

Q5 ICUダイアリーは患者のPTSDを防ぐ

確認クイズの答え

Q1 ✕ 効いたのは家族の不安・抑うつ・PTSD

Q2 ✕ 自分から訴えたのは20%だけ

Q3 ✕ 口渇と口腔の水分は関連しない

Q4 ○ ただし非ランダム化の関連

Q5 ✕ 657例のRCTで差なし

ご清聴ありがとうございました

元気とユーモアを忘れずに、Human care の実践を